

Lippenbändchen und Zungenbändchen

Wann eine Korrektur sinnvoll sein kann, wie die V-Y-Plastik abläuft und was Sie danach beachten sollten.

Diese Information richtet sich an Erwachsene sowie an Eltern und ihre Kinder. Wir besprechen mit Ihnen, welches Bändchen behandelt werden soll und welches konkrete Ziel erreichbar ist. Bei Säuglingen werden Untersuchung, Verfahren und Nachsorge gesondert festgelegt.

Eine normale Struktur kann zu viel Zug ausüben

Lippenbändchen verbinden die Lippeninnenseite mit der Schleimhaut am Kiefer. Das Zungenbändchen verbindet die Zungenunterseite mit dem Mundboden. Länge, Ansatz und Beweglichkeit sind unterschiedlich.

Ein sichtbares oder kräftiges Bändchen allein ist kein Grund für eine Operation. Entscheidend sind Beschwerden und Funktion.

Oberlippenbändchen

Ein ungünstiger Ansatz kann Zahnfleischzug verursachen und Reinigung oder Lippenbewegung erschweren. Bei einer bleibenden oberen Schneidezahnlücke wird der Beitrag des Bändchens geprüft und die Behandlung mit der Kieferorthopädie abgestimmt.

Zungenbändchen

Ein straffes Bändchen kann Zungenhebung und -bewegung einschränken. Entscheidend sind Beschwerden beim Essen, der Mundreinigung oder bestimmten Sprechbewegungen. Bei Sprechproblemen ist eine logopädische Beurteilung wichtig.

Unterlippenbändchen und Rezessionen

Ein hoch ansetzendes Unterlippenbändchen kann beim Bewegen der Lippe Zug auf den Zahnfleischrand ausüben, besonders an den unteren Schneidezähnen. Das kann **Zahnfleischrückgang (Rezessionen) auslösen oder begünstigen**; dabei werden Wurzeloberflächen freigelegt und können empfindlich werden. Meist wirken mehrere Faktoren zusammen, etwa Entzündungen, kräftiges Putzen oder dünnes Zahnfleisch.

Wir prüfen den Bändchenzug und den Zustand des Zahnhalteapparats. Zunächst beziehungsweise begleitend werden Mundhygiene, Putztechnik und Entzündungen behandelt. Bei relevantem Zug kann eine Korrektur sinnvoll sein. **Sie vermindert den Zug, deckt eine bestehende Rezession aber nicht automatisch.** Eine zusätzliche parodontale Behandlung oder chirurgische Wurzeldeckung wird bei Bedarf gesondert geplant.

Der richtige Zeitpunkt

Eine Schneidezahnlücke kann im Zahnwechsel normal sein. Der Zeitpunkt einer Oberlippenbändchenkorrektur wird mit der Kieferorthopädie abgestimmt; häufig wird die weitere Zahnentwicklung beziehungsweise der geplante Lückenschluss abgewartet. **Die Operation allein schließt keine Zahnlücke.**

Säuglinge mit Trinkproblemen: Zuerst werden Stillen beziehungsweise Füttern, Gewichtsentwicklung und andere Ursachen kinderärztlich und durch qualifizierte Still-/Fütterberatung beurteilt. Ein Zungenbändcheneingriff kommt nur bei relevanter funktioneller Einschränkung und fortbestehenden Problemen trotz Unterstützung infrage. Ein auffälliges Lippenbändchen oder mögliche spätere Sprachprobleme allein rechtfertigen keine vorsorgliche Operation.

Unser übliches Verfahren: V-Y-Plastik

Bei einer V-Y-Plastik wird die Schleimhaut gezielt gelöst, verlagert und verlängert. Ein zunächst **V-förmig angelegter Bereich wird Y-förmig vernäht**. Dadurch soll störender Zug vermindert und mehr Bewegungsfreiheit erreicht werden. Die genaue Schnittführung hängt davon ab, welches Bändchen betroffen ist und wie viel Gewebe zur Verfügung steht.

1. **Planen:** Wir prüfen Funktion, Gewebezug und Nachbarstrukturen. Bei Bedarf stimmen wir uns mit Zahnmedizin, Kieferorthopädie, Logopädie oder Kinderheilkunde ab.
2. **Betäuben:** Der Eingriff beginnt erst, wenn die Betäubung wirkt. Druck und Berührung können bei örtlicher Betäubung spürbar sein. Schmerzen bitte sofort signalisieren.
3. **Lösen und verlagern:** Das einschränkende Gewebe wird unter Schonung der Umgebung gelöst und die Schleimhaut entsprechend dem Befund verschoben.
4. **Vernähen und kontrollieren:** Wir stillen die Blutung, prüfen die erreichte Beweglichkeit und schließen die Wunde mit feinen Nähten möglichst spannungsarm.

Der Eingriff erfolgt üblicherweise ambulant. Umfang, Betäubung und Mitarbeit bestimmen den Zeitbedarf. Fäden werden je nach Material nach **1–2 Wochen entfernt** oder lösen sich selbst auf. Den Kontrolltermin vereinbaren wir individuell.

Was kann die Behandlung erreichen?

Das Ziel ist eine funktionelle Entlastung. Eine sofort normale Sprache, eine bestimmte Zungenbeweglichkeit oder ein bleibender Lückenschluss lassen sich nicht zusagen. Eingübte Bewegungsmuster können nach der Heilung weitere Therapie benötigen. Die im Mund entstehende Narbe kann erneut ziehen; eine Wiederanheftung oder ein erneuter Eingriff sind möglich.

Welche Alternativen gibt es?

Je nach Befund sind Beobachtung, Mundhygieneanleitung, Logopädie, angeleitete Funktionsübungen oder eine kieferorthopädische Behandlung sinnvoll. Ein straffes Gewebeband wird dadurch nicht immer ausreichend entlastet. Operativ kommen auch eine einfache Durchtrennung, Entfernung störender Gewebeanteile oder eine andere plastische Schnittführung infrage. Wir erläutern, was bei Ihnen geeignet ist.

Ohne Eingriff können Zug oder Bewegungseinschränkung bestehen bleiben. Nicht jeder Befund verschlechtert sich; ohne relevante Beschwerden kann Abwarten die passende Entscheidung sein.

Kosten vorab klären

Abrechnung und Kostenübernahme richten sich nach medizinischer Indikation, Aufwand und Versicherung. Wir klären vor dem Eingriff, welche Leistungen übernommen werden und ob **individuell vereinbarte Eigenleistungen** entstehen. Betäubungs- und Komfortleistungen werden gesondert besprochen.

Mögliche Risiken und Komplikationen

Auch ein kleiner Eingriff kann Beschwerden oder eine zusätzliche Behandlung nach sich ziehen. Das persönliche Risiko hängt unter anderem vom Befund, Voroperationen, Allgemeinerkrankungen, Medikamenten und der Wundpflege ab.

- **Wunde und Heilung:** Schmerzen, Schwellung, Bluterguss, Nachblutung, Infektion, Nahtöffnung und verzögerte Heilung. Eine erneute Blutstillung oder Naht kann nötig werden.
- **Narbe und Funktion:** störender Narbenzug, Wiederanheftung oder verbleibende Einschränkung; selten Verschlechterung der Beweglichkeit. Manchmal sind weitere Therapie oder eine Nachkorrektur erforderlich.
- **Am Lippenbändchen:** Verletzung benachbarter Schleimhaut oder des Zahnfleisches, Zahnfleischrückgang und veränderte Kontur. Eine Zahnlücke kann bestehen bleiben oder erneut entstehen.
- **Am Zungenbändchen:** Verletzung von Gefäßen, Speicheldrüсengängen oder Nerven. Möglich sind Speichelstau beziehungsweise eine Speichelzyste sowie vorübergehende oder bleibende Gefühls-, Geschmacks- oder Bewegungsstörungen.
- **Seltene ernste Verläufe:** starke Blutung oder Mundbodenschwellung mit Schluck- oder Atembehinderung. Bei rascher Schwellung oder Atemnot sofort 112.
- **Betäubung und Medikamente:** Unverträglichkeiten, allergische Reaktionen, Kreislauf- oder Atemprobleme. Bei Sedierung oder Vollnarkose erfolgt zusätzlich eine gesonderte Anästhesieaufklärung.

Wundpflege und Alltag

Bis die Betäubung abgeklungen ist: nichts kauen und nichts Heißes trinken. Kinder beaufsichtigen, damit sie nicht auf Lippe oder Zunge beißen. Anschließend weiche, lauwarne Nahrung wählen und ausreichend trinken. Säuglinge erhalten einen eigenen Fütterplan.

Zähne vorsichtig mit einer weichen Bürste reinigen. Die Naht nicht scheuern oder mit Fingern bearbeiten. Am OP-Tag nicht kräftig spülen oder spucken; weitere Spülungen und Medikamente nur nach Anleitung. Nicht rauchen oder dampfen, während der ersten Heilungsphase keinen Alkohol trinken. In den ersten Tagen körperlich schonen; Sport und stärkere Belastung nach Verlauf und Freigabe.

Bewegen nach Plan, nicht gewaltsam dehnen. Zungen- oder Lippenübungen stimmen wir auf Befund, Naht und Heilungsverlauf ab, bei Bedarf mit der Logopädie. Wunde nicht auseinanderziehen, aufreißen oder selbst wieder öffnen. Eine allgemeine Dehnroutine für alle – insbesondere für Säuglinge – ist nicht vorgesehen.

Betäubung und Komfortmöglichkeiten

Methode	Beschreibung	Kosten
Lokalanästhesie Standard	Wach, kein Schmerz – nur Druck. Bei Schmerzwahrnehmung wird sofort nachbetäubt. ÖPNV nach Hause erlaubt.	Kassenleistung (GKV) bzw. im Behandlungspaket inkl.
Orale Sedierung (Tavor) Komfort	Tablette ca. 60 Min. vorher. Kein Schlaf, deutliche Stressreduktion. Vitalparameter werden überwacht. Begleitperson notwendig, 24 Std. nicht verkehrsfähig. Abholung aus der Praxis verpflichtend.	ca. 80 € Eigenleistung
Dämmerschlaf (i.v.) Komfort	Professionelles Narkoseteam, medikamentös an der Schlaf-Wachgrenze, kooperativ, meist keine Erinnerung. Postop. Aufwachraum mit Vitalüberwachung. Nur dienstags. Nüchtern ab 22 Uhr nichts essen, ab 6 Uhr nichts trinken. Abholung aus der Praxis verpflichtend.	ca. 230 € Eigenleistung
Vollnarkose Komfort	Echter Tiefschlaf, Beatmung über die Nase in die Lunge, keine Wahrnehmung des Eingriffs. Postop. Aufwachraum mit Vitalüberwachung. Nur dienstags. Nüchtern wie Dämmerschlaf. Abholung aus der Praxis verpflichtend.	ca. 450 € Eigenleistung

Standard ist die Lokalanästhesie – für die allermeisten Patienten vollkommen ausreichend. Sedierung ist eine optionale Komfortzubuchung als Eigenleistung. Bei keiner Methode spüren Sie Schmerzen – die Betäubung wirkt vollständig, bevor wir beginnen.

Für Kinder und Jugendliche wählen wir das Verfahren individuell nach Alter, Gesundheitszustand und Mitarbeit. Tavor ist keine pauschale Empfehlung für Minderjährige. Die persönlich vereinbarten schriftlichen Nüchtern- und Medikamentenanweisungen haben Vorrang. Eine medizinisch notwendige Narkose und eine mögliche Kostenübernahme werden gesondert geprüft.

Was wir vor dem Termin wissen müssen

- Medikamentenliste, Allergien, Gerinnungsstörungen, frühere Nachblutungen und Voroperationen angeben. Blutverdünner einschließlich ASS nicht eigenständig absetzen.
- Diabetes, Immunsuppression, relevante Herz-/Lungenerkrankungen und mögliche Schwangerschaft nennen.
- KFO- oder logopädische Befunde sowie das vereinbarte Behandlungsziel mitbringen. Bei Minderjährigen Sorgeberechtigung und Begleitung klären.
- Bei örtlicher Betäubung normalerweise vorher leicht essen. Bei Sedierung/Narkose ausschließlich die individuell vereinbarten Nüchternheitsanweisungen befolgen.

Heimweg: Nach Lokalanästhesie kein Auto, Fahrrad oder Motorrad führen; ÖPNV ist grundsätzlich möglich. Minderjährige kommen mit Begleitperson. Nach Sedierung oder Narkose sind Abholung aus der Praxis und Betreuung erforderlich; mindestens 24 Stunden keine Fahrzeuge oder Maschinen bedienen, keinen Alkohol trinken und keine wichtigen Entscheidungen treffen.

Schmerzen behandeln

Kinder und Jugendliche erhalten einen eigenen Plan nach Alter und Gewicht. Die folgende Tabelle nennt den Erwachsenen-Praxisstandard und gilt nur nach individueller Freigabe. Vorerkrankungen, Körpergewicht und andere Medikamente können niedrigere Dosen oder andere Mittel erfordern.

Mittel	Einnahme bei Eignung	Hinweis
Ibuprofen 600 mg	Alle 6–8 Std., max. 3×/Tag	Nicht nüchtern
Paracetamol 500–1000 mg	Alternativ/ergänzend alle 6 Std.	Max. 4 g/Tag; nicht für alle Körpergewichte geeignet
Novalgin-Tropfen	Bis zu 4×30 Tropfen täglich, nur verordnet	Nur bei 500 mg/ml und 20 Tropfen/ml
Kein Aspirin/ASS zusätzlich	Als Schmerzmittel meiden	Verordnete ASS-Dauertherapie nicht selbst absetzen

Bei Fieber, Schüttelfrost, Halsschmerzen oder schmerzhaften Schleimhautveränderungen unter Novalgin/Metamizol: **sofort absetzen und dringend ärztlich abklären**. Keine paracetamolhaltigen Kombinationsmittel zusätzlich ohne Rücksprache einnehmen.

Heilung und Kontrollen

- **Erste Tage:** Wundschmerz, Schwellung und ungewohnte Bewegungen sind möglich; die Beschwerden sollten im Verlauf nachlassen.
- **Nach etwa 1–2 Wochen:** Wund- und Funktionskontrolle, gegebenenfalls Fadenentfernung. Ein weißlicher Wundbelag kann zur Heilung gehören; nicht abkratzen.
- **Folgende Wochen:** Die Narbe reift, die Beweglichkeit wird erneut beurteilt. Logopädische Übungen beziehungsweise KFO-Behandlung werden nach abgestimmtem Plan fortgeführt.

Bei Warnzeichen sofort Kontakt aufnehmen

Anhaltende Blutung, deutlich zunehmende Schmerzen oder Schwellung, Fieber, Eiter oder unzureichendes Trinken: Praxis **06151 786540**.

Nach dem Eingriff außerhalb der Praxisprechzeiten: **+49 151 10437450**. Falls nicht erreichbar: zahnärztlicher Notdienst **01805 60 70 11**.

Bei lebensbedrohlicher Notlage, Atemnot, starker Schluckbehinderung oder rascher Schwellung von Mundboden, Hals oder Zunge **sofort 112**.

Häufige Fragen

Wird die Zunge durch den Eingriff länger?

Die Zunge selbst wird nicht verlängert. Gelöst beziehungsweise verlängert wird das einschränkende Gewebe, damit die vorhandene Zunge mehr Bewegungsfreiheit erhalten kann.

Verschwindet eine Sprachstörung danach von allein?

Das ist nicht gesichert. Wir prüfen zusammen mit der Logopädie, ob das Bändchen für die beobachteten Schwierigkeiten relevant ist. Auch nach einer Operation kann Übungsbehandlung notwendig bleiben.

Muss ein kräftiges Lippenbändchen immer entfernt werden?

Nein. Ohne störenden Zug oder eine klar begründete funktionelle beziehungsweise kieferorthopädische Indikation ist häufig keine Operation nötig.

Sind Spüllösung und Antibiotika immer nötig?

Nein. Sie werden nur bei entsprechender Indikation verordnet. Für kleine Kinder sind nicht alle Spüllösungen geeignet; nichts eigenständig anwenden.

Was tun bei Blutung oder wenn mein Kind nicht trinken möchte?

Bei anhaltender Blutung oder deutlich zu wenig Flüssigkeitsaufnahme die Praxis umgehend kontaktieren. Bei sicherer Mitarbeit kann sanfter Druck mit einem sauberen Tupfer auf die zugängliche Wunde helfen. Kleine Kinder niemals mit einem losen Tupfer im Mund unbeaufsichtigt lassen. Unter der Zunge nicht blind drücken oder tief im Mund hantieren.

Checkliste für Ihre Behandlung

- Betroffenes Bändchen, konkrete Einschränkung und realistisches Ziel sind geklärt.
- Alternativen, Risiken, Betäubung und Kosten wurden besprochen.
- Medikamentenplan, Begleitung und gegebenenfalls Nüchternheit sind vereinbart.
- Kontrolltermin, Nahtversorgung und Beginn möglicher Übungen stehen fest.
- Kontaktwege bei Warnzeichen sind bekannt.



Online lesen oder weitergeben

patienteninfo.mkg-im-carree.de/baendchen/

QR-Code mit dem Smartphone scannen.

Fachliche Grundlagen: AAPD: Management of the Frenulum (2022; Reference Manual 2025); AAP: Ankyloglossia and breastfeeding (2024); Evelina London: Tongue-tie surgery; East Sussex Healthcare NHS: Frenectomy; V-Y plasty for abnormal frenal attachment (case report, 2024). Abruf 25.09.2026. Praxisablauf: MKG im Carree. Diese Information ergänzt das persönliche Aufklärungsgespräch.